



TXAGORRITXU OSPITALEA
H. TXAGORRITXU

GUINEA IBAÑEZ DE GARAYO
Deiturak / Apellidos

LUIS MARIA
Izena / Nombre

TOMAS ALFARO, 0013 007 A
1008 VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)

Helbidea / Dirección

URGENCIA

URGENCIAS DE MEDICINA

Historia Zk. / Nº Historia IKK / CIC Gizarte Segurantzak / Nº Seguridad Social

536665 1164816 10015586764

Jaiotze Data / F. Nacimiento

15/05/1956

Gertakari Zk. / Nº Episodio

2494706

Sarrera Data / F. Ingreso

18/10/2019 06:03

Alta Data / F. Alta

18/10/2019 09:40

Zerbitzu / Servicio

URGENCIAS GENERALES

Profesional / Profesional

AZCONA ALIENDE, ENEKO

Varón de 63 años.

ANTECEDENTES PERSONALES

- Sin alergia medicamentosa conocida.
- HTA.
- Hiperlipidemia.
- Accidente de bicicleta en el año 2003: TCE grave con fractura de base craneal y fractura temporal izquierda. Hematoma epidural temporal izquierdo. Hematoma subdural temporo-parietal izquierdo. Hemorragia subaracnoidea traumática. Importante desviación de línea media con borramiento de cisternas basales. Preciso tratamiento de rehabilitación por presentar una afasia mixta de predominio motor. Discreta hemiparesia derecha.
- Epilepsia. Última crisis en 2010, generalizada t-c.
- Fístula arteriovenosa dural del seno sigmoide derecho tratada endovascularmente 17 de septiembre de 2018. En control por neuroradiología. Ingresó en junio/19 para control angiográfico con resultado de correcta embolización.
- Antecedentes quirúrgicos: Varices (Dic 2017). Sutura tendón mano 2017 con AG, colonoscopia, evacuación de hematoma subdural y epidural y craniectomía descompresiva por TCE grave en 2003. Fractura humero.

- Tratamiento habitual (conciliado):

ATENOLOL 100MG 1 COMPRIMIDO DESAYUNO
FELODIPINO 5MG 1 COMPRIMIDO DESAYUNO
SIMVASTATINA 20MG 1 COMPRIMIDO ACOSTARSE
LORAZEPAM 1MG 1 COMPRIMIDO ACOSTARSE

ENFERMEDAD ACTUAL

Paciente que consulta por sensación de palpitaciones anormales de comienzo a las 5:00 h aproximadamente que le ha despertado y que no ha cedido. No refiere dolor torácico ni disnea. No síncope ni mareo. No náuseas ni vómitos. Refiere primer episodio de esta intensidad, con algún episodio previo ocasional hace 1 año autolimitado y leve que él relaciona con situaciones de estrés.

EXPLORACIÓN GENERAL

Bien nutrido e hidratado. Buena coloración de piel y mucosas. Eupneico en reposo.

.- Constantes vitales:

.- Cabeza y cuello: Orofaringe normal. No adenopatías. No IY.

FIRMADO:

010104198 AZCONA ALIENDE, ENEKO

FECHA INFORME: 18/10/2019

HORA INFORME: 9:54

PÁGINA: 1 / 3



Osakidetza

TXAGORRITXU OSPITALEA
H. TXAGORRITXU

GUINEA IBAÑEZ DE GARAYO
Deiturak / Apellidos

LUIS MARIA
Izena / Nombre

TOMAS ALFARO, 0013 007 A
1008 VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)

Helbidea / Dirección

URGENCIA

URGENCIAS DE MEDICINA

- A.C.: Arrítmica.
- A.P.: Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

- ECG: FA a 109 lpm. BRD incompleto. Sin alteraciones de la repolarización.

- Análisis de sangre:

BIOQUIMICA GENERAL

Srm-Glucosa	105 mg/dL	60 - 110
Srm-Urea	25 mg/dL	10 - 50
Srm-Creatinina	0,96 mg/dL	0,5 - 1,4
Srm-Sodio	140 mEq/L	135 - 146
Srm-Potasio	4,2 mEq/L	3,5 - 5,5
Srm-Cloruro	105 mEq/L	95 - 110

HEMATOLOGIA GENERAL

San-Hemograma		
San-Hemáties	5,10 *10 ⁶ /μL	4,5 - 5,9
San-Hemoglobina	16,6 g/dL	13 - 17,7
San-Hematocrito	48,9 %	40 - 53
San-Volumen corpuscular medio (VCM)	95,9 fL	78 - 101
San-Amplitud de distribución eritrocitaria		

(ADE) 11,6 % 11,5 - 14,5

San-Hemoglobina corpuscular media eritrocitaria

(HCM) 32,6 pg 27 - 33

San-Concentración de hemoglobina corpuscular

media 34,0 g/dL 30,5 - 35,5

San-Plaquetas	181 *10 ³ /μL	100 - 450
San-Volumen medio plaquetario	* 7,0 fL	7,4 - 11
San-Leucocitos	4,60 *10 ³ /μL	4 - 11

San-Formula leucocitaria

San-Neutrófilos	53,10 %	30 - 70
San-Linfocitos	34,40 %	25 - 50
San-Monocitos	10,50 %	0 - 25
San-Eosinófilos	1,51 %	0 - 5
San-Basófilos	0,55 %	0 - 1
San-Neutrófilos	2,44 *10 ³ /μL	1,5 - 7,7
San-Linfocitos	1,58 *10 ³ /μL	1,1 - 4,5
San-Monocitos	0,48 *10 ³ /μL	0,1 - 1,0
San-Eosinófilos	0,07 *10 ³ /μL	0 - 0,5
San-Basófilos	0,03 *10 ³ /μL	0,0 - 0,2

HEMOSTASIA

Pla-Tiempo de tromboplastina parcial activada

(TTPA) 36 sg 0 - 40

Pla-Tiempo de tromboplastina parcial activada

(TTPA)(ratio) 1,15 0,00 - 1,30

Pla-Tiempo de protrombina (sg) 10,90 sg

Pla-Tiempo (Índice) de protrombina (%) 109 %

Pla-INR (Ratio Internacional Normalizada) 1,0 0,8 - 1,2

Pla-Fibrinogeno (derivado) 452 mg/dL 150 - 500

- Rx tórax: sin hallazgos significativos.

FIRMADO:

010104198 AZCONA ALIENDE, ENEKO

FECHA INFORME: 18/10/2019

HORA INFORME: 9:54

PÁGINA: 2 / 3

15



Osakidetza

TXAGORRITXU OSPITALEA
H. TXAGORRITXU

GUINEA IBAÑEZ DE GARAYO
Deiturak / Apellidos

LUIS MARIA
Izena / Nombre

TOMAS ALFARO, 0013 007 A
1008 VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ALAVA)

Helbidea / Dirección

URGENCIA

URGENCIAS DE MEDICINA

TRATAMIENTO RECIBIDO EN URGENCIAS

- Vernakalant
- Clexane 150mg sc ahora

EVOLUCIÓN

CHA2DS2-VASc: 1
HAS-BLED: 1

Revierte a ritmo sinusal, se mantiene en RS.

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

- Fibrilación auricular revertida

TRATAMIENTO DE ALTA

- Enoxaparina 150mg 1 sc 1 al día durante 4-5 días según protocolo.
- Cita preferente en consultas de cardiología.
- Se explican signos de alarma.
- Control por su médica de cabecera.

FIRMADO:

010104198 AZCONA ALIENDE, ENEKO

FECHA INFORME: 18/10/2019

HORA INFORME: 9:54

PÁGINA: 3 / 3

15

